

БЕКТЕМ

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо жана социалдык
өнүктүрүү министрлигинин астындагы
Дары каражаттары жана медициналык
буюмдар департаментинин
директорунун орун басары
Мамбеталиева Ч. М.

«18»

2021-ж.

**ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА
НУСКАМА**

АМОДАКС

Соодадагы аталышы: Амодакс.

Эл аралык патенттелбеген аталышы: Амоксициллин.

Дарынын түрү

Ичип кабыл алуу үчүн суспензияны даярдоо арналган порошок.

Курамы

Амодакс 125мг/5мл

Ар бир 5 мл даяр суспензиялар төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү зат:

Амоксициллин тригидрат ВР

амоксициллинге туура келет 125 мг

Көмөкчү заттар: суусуз коллоиддүү кремний диоксиди, натрий кармеллозасы, сахароза, натрий бензоаты, сары Супра сансет боёгучу, апельсин кургак жыпар жыт бергичи, тазартылган тальк, ксантан чайыры.

Амодакс 250мг/5мл

Ар бир 5 мл даяр суспензиялар төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү зат:

Амоксициллин тригидрат ВР

амоксициллинге туура келет 250 мг

Көмөкчү заттар:

суусуз коллоиддүү кремний диоксиди, натрий кармеллозасы, сахароза, натрий бензоаты, тазартылган тальк, апельсиндин кургак жыпар жыт бергичи, сары Супра сансет боёгучу.

Сүрөттөмөсү

Амодакс 125мг/5мл: Аралаштырууда сары кызгыл түстөгү суспензияны пайда кылуучу гранулданган порошок.

Амодакс 250мг/5мл: Аралаштырууда сары кызгыл түстөгү суспензияны пайда кылуучу, дээрлик ак түстөн ачык-кызгылт түскө чейинки гранулданган порошок.

Фармадарылык тобу: Системалуу таасир берүүчү жалпы бактерияга каршы каражаттар. Системалуу таасир берүүчү бактерияга каршы каражаттар. Системалуу таасир берүүчү бета-лактамдык антибиотиктер. Кеңири чөйрөдө таасир берүүчү пенициллиндер. Амоксициллин.

АТХ коду: J01CA04.

Фармакологиялык касиеттери

Фармакодинамикасы.

Амоксициллин –кеңири чөйрөдө таасир берүүчү бактерияга каршы каражат. Транспептидазаны басандатат, ошону менен эле бөлүнүү мезгилинде пептидогликандын (анын бекемдигин касыздоочу бактериянын клеткалык капталынын структуралык мукопептиди) синтезин жана микроорганизмдердин өсүүсүн бузат жана микроорганизмдердин лизисин пайда кылат. Амоксициллин микробго каршы таасирдин кеңири чөйрөсүнө ээ:

Аэробдук грам оң микроорганизмдер: *Staphylococcus* spp. (, P-лактамазаны продуцирлөөчү штаммдардан башка), *Streptococcus* spp., ошондой эле *Streptococcus faecalis*, *Streptococcus pneumonia*, *Enterococcus faecalis*. Аэробдук грам терс микроорганизмдер: *Neisseria gonorrhoeae* (, P-лактамазаны продуцирлөөчү штаммдардан башка), *Neisseria meningitides*, *Escherichia coli* (, p-лактамазаны продуцирлөөчү штаммдардан башка), *Proteus mirabilis* (P-лактамазаны продуцирлөөчү штаммдардан башка), *Haemophilus influenzae* (p-лактамазаны продуцирлөөчү штаммдардан башка), *Helicobacter pylori*, кээ бир штаммдар *Salmonella*, *Shigella*, *Klebsiella*.

Фармакокинетикасы.

Амоксициллин туздуу кислотанын болушунда туруктуу, ичип кабыл алууда тез жана жакшы сиңирилет, организмдин ткандарында дана суюктуктарында. 125мг/5мл жана 250 мг/5мл дозаларда суспензияларды кабыл алууда кандагы максималдуу концентрациялар (1,5-3,0 мкг/мл жана ылайыгына жараша 3,5-5,0 мкг/мл) ошондой эле 1-2 сааттан кийин жетет. Кандын плазмасындагы белоктор менен байланышуу 20% га жакын. Гистогематикалык бөгөттөөлөргө жеңил өтөт, ГЭБ башка (сезгенүүдө өткөрүүмдү болуп калат), организмдин көбүнчө ткандарына жана суюктуктарына тезинен өтөт; перитонеалдык суюктуктарда, заарада, тери ыйлаакчаларынын курамында, өпкө челинен боштукта, өпкөнүн ткандарында, ичегилердин былжырлуу чел кабыгында, аялдардын жыныстык органдарында, орто кулактын суюктуктарында, өт баштыкчасында жана өтө дарылык концентрацияларда топтолот.

Жарым жартылай бөлүнүү мезгили 1-1,5 саат. Амоксициллиндин көбүнчө бөлүгү (50-70%) каналчалуу секреция жолу менен өзгөрүлбөгөн түрдө (80%) бөйрөктөр менен жана түйдөкчөлүү чыпкалоо (20%) менен 6-8 саат мезгил ичинде бөлүнүп чыгат. Кабыл алынган амоксициллиндин дозасынын 10-20% боор менен бөлүнүп чыгат. Ичип кабыл алуудан кийин 8 саат ичинде сары сууда аныкталат. Бөйрөк функциясынын бузулуусунда жарым жартылай бөлүнүү мезгили 4-12,6 маатка чейин узарат.

Колдонууга көрсөтмө

Сезгичтүү микроорганизмдер менен пайда болгон бактериялык инфекциялар:

- Streptococcus spp. пайда кылган дем алуу жолдорунун жана кмт-органдардын инфекциялары, (а жана b гемолитикалык штаммдар), Spneumoniae, Staphylococcus spp., H influenza;
- E. coli, P. mirabilis, E.faecalis пайда болгон, заара жыныстык системасынын инфекциялары;
- N. Gonorrhoeae пайда болгон эркектердеги жана аялдардагы курч өрчүп кетпеген гонорея;
- абдоминалдык инфекциялар жана АИЖ инфекциялары (ич келтеси, дизентерия, сальмонеллез, сальмонеллездук алып жүрүүчүлүк);
- Streptococcus spp. (а жана b гемолитикалык штаммдар) пайда болгон тери жана жумшак ткандардын инфекциялары, Staphylococcus spp., E.coli;
- лептоспироз, листериоз, Лайма оорусу;
- эрадикация Helicobacter pylori (айкалышкан дарылоонун курамында);
- эндокардиттин өрчүүсүнүн жогорку кооптуулугу менен бейтаптарда инфекциондук эндокардитти алдын алуу (тиш жулдуруу, аорткоронарография жана башкалар).

Каршы көрсөтмө

- оору тажымалында бета-лактамыдык антибиотиктерге гиперсезгичтүүлүк;
- инфекциялык моноклеоз.
- аллергиялык диатез;
- колко астмасы, поллиноз;
- лимфолейкоз;
- боор алсыздыгы;
- оору таржымалында АИЖ оорусу (өзгөчө антибиотиктерди кабыл алуу менен байланыштуу колит);

Этияттуулук менен препаратты бөйрөк алсыздыгында, ошондой эле оору таржымалында кан кетүүгө көрсөтмөсү болгондо этияттуулук менен дайындоо керек.

Колдонуу жолу жана дозалары

Инфекциянын оордугун эске алуу менен жекече аныкталат.

Чоңдорго жана 10 жаштан жогорку балдарга адатта суткасына 3 жолу 500 мг дан дайындалат. Инфекциянын оор агымында доза суткасына 3 жолу 1,0 гга чейин жогорулатылышы мүмкүн.

10 жашка чейинки же 40 кг дан азыраак дене салмагы менен балдар

Балдар үчүн суткалык доза оорунун көрсөтмөсү жана оордугуна жараша суткасына 3 кабыл алуу менен (суткасына максималдуу 60 мг/кг в) 20 - 50 мг/кг ды түзөт.

10 жашка чейинки курактагы балдарга мүмкүн болушунча препаратты суспензия түрүндө дайындоо керек.

2 жашка чейинки балдарга суткалык доза 3 кабыл алууга 20 мг/кг.

2 ден 5 жашка чейинки балдарга суткасына 3 жолу 125 мг суспензиядан.

5-10 жаштагы балдарга адатта суткасына 3 жолу 250 мг суспензиядан.

Айына жетпей төмөлгөндөргө жана жаңы төрөлгөндөргө дозаны кабыл алуунун ортосундагы аралыкты төмөндөтөт жана/же жогорулатат.

Алдын ала дайындоонун өзгөчөлүктөрү (процедурага чейин 30-60 минута мурун).

Амодакс препараты менен дарылоо курсу 5-14 күндү түзөт.

Аны даярдоо үчүн флаконду ачуу керек, белгиге чейин кайнатылып муздаган сууну кошуу зарыл жана бир нече жолу жакшылап чайкоо керек. 1 чай кашыкта (5 мл) 125 мг препарат камтылган.

Бөлмө табында сакталган даярдалган суспензия, 7 сутка ичинде колдонууга жарактуу.

Кыйыр реакциялар

Аллергиялык реакциялар: бөрү жатыш, тери гиперемиясы, эритема, ангионевротикалык шишимик, ринит, конъюнктивит болушу мүмкүн; сейрек - калтырак, муундардын оорусу, эозинофилия, эксфолиативдик дерматит, көп формалуу экссудативдик эритема, Стивенс-Джонсон синдрому; сары суулук ооруга окшош реакциялар; айрым учурларда – анафилактикалык шок.

Тамак-аш сиңирүү системасы тарабынан: дисбактериоз, даам сезүүнүн бузулуусу, кусуу, көңүл айнуу, ич өтүү, стоматит, глоссит, боор трансаминазаларынын активдүүлүгүнүн орточо жогорулоосу, алган мембраноздук энтероколит.

Нерв системасы тарабынан: дүүлүгүү, тынчсыздануу, уйкусуздук, атаксия, акыл-эстин чаташуусу, жүрүм-турумдун өзгөрүүсү, депрессия, перифериялык невропатия, баш ооруу, баш айлануу, карышуу реакциялары.

Лабораториялык көрсөткүчтөр: лейкопения, нейтропения, тромбоцитопениядык пурпура, аз кандуулук.

Башкалар: дем алуунун оорлошу, тахикардия, интерстициалдык нефрит, кын кандидозу, суперинфекция (өзгөчө өнөкөт оорулары бар жана организмдин төмөнкү резистенттүүлүгү менен бейтаптарда).

Ашыкча доза

Симптомдору: көңүл айнуу, кусуу, ич өтүү, көңүл айнуу жана кусуунун жыйынтыгы сыяктуу суулуу-электролиттик баланстын бузулуусу. Андан аркы олигурия менен коштолгон интерстициалдык нефриттин өөрчүүсү тууралуу бир канча учурлар айтылган. Амоксициллинди дозасынан ашыруудан кийин кристаллуриянын өнүккөн учурлары тууралуу билдирилген, ал айрым учурларда бөйрөк алсыздыгына алып келген. Жогорку дозаларда узак убакыттын аралыгында колдонууда – нейротоксиндүү реакциялар жана тромбоцитопения (препаратты токтотуудан кийин жок болушат).

Дарылоо: ашказанды жуу, активдеширилген көмүрдү, туздуу ич айдоочу каражаттарды дайындоо, суулуу - электролиттик балансты оңдоп-түзөтүү, суюктукту жетиштүү алуу жана диурезге колдоо көрсөтүү (кристаллурия коркунучун азайтуу үчүн). Гемодиализ аркылуу циркуляциялык кандан амоксициллиндин ашыкча көлөмүн жок кылууга болот.

Башка дары каражаттар менен өз ара таасири

Хлорамфеникол, макролиддер, сульфониламиддер, линкозамиддер жана тетрациклиндер (бактериостатикалык антибиотиктер) амоксициллиндин бактерициддик таасирине тоскоолдук жаратышы ыктымал.

Эстроген-камтыган пероралдык контрацептивдик препараттар: ашказан-ичеги микрофлорасына таасири эстрогендин реабсорбциясынын төмөндөшүнө жана айкалышкан контрацептивдик препараттардын натыйжалуулугунун төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн.

Амоксициллин клиренсти төмөндөтөт жана метотрексаттын уулуулугун жогорулатат.

Кыйыр антикоагулянттар: ашказан-ичеги микрофлорасынын басынтылышынан, К витамининин жана протромбин индексинин төмөндөшүнөн улам кыйыр антикоагулянттардын натыйжалуулугу жогорулашы ыктымал.

ССКК, диуретиктер, аллопуринол, пробеницид жана каналчалуу секрецияны басынтууга жөндөмдүү башка ДК: Амоксициллин менен бир мезгилде чогуу кабыл алуу кандагы амоксициллиндин концентрациясын жогорулатышы жана жарым-жартылай бөлүнүп чыгуу мезгилин көбөйтүшү мүмкүн.

Антациддер жана энтеросорбенттер (активдештирилген көмүр, ак чопо ж.б.): амоксициллинди бир убакытта чогуу кабыл алуу учурунда анын сиңишин азайтууга болот. Кабыл алуу ортосундагы аралык кеминде 2 саат болушу керек.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Анафилактикалык реакциялардын өнүгүү коркунучу пенициллиндик антибиотиктерге болгон сезимталдык реакциясы же оору таржымалында көп аллергияларга жогорку сезгичтиги бар бейтаптарда жогору. Амодакс препаратын дайындоодон мурун, бейтаптын пенициллиндерге, цефалоспориндерге же башка аллергияларга болгон мурунку аллергиялык реакциялары жөнүндө маалыматты кылдаттык менен чогултуу жана баалоо керек. Аллергиялык реакциялардын өнүгүшү менен препаратты дароо токтотуу жана аллергиялык реакцияны токтотуу чараларын көрүү керек. Олуттуу анафилактикалык реакциялар адреналин, көк кан тамыр ичине глюкокортикостероиддерди куюу жана зарылдыгына жараша дем алууну камсыздоо, анын ичинде интубацияны башкаруу менен купирленет.

Дээрлик баардык бактерияга каршы препараттарды, анын ичинде амоксициллинди кабыл алууда, оордук даражасы боюнча жеңил түрүнөн жашоо үчүн коркунуч келтирүүчү абалган чейинки жалган мембраноздуу колит өнүгүүсү мүмкүн. Буга байланыштуу бактерияга каршы препараттарды кабыл алууну фонунда ич өтүү өнүккөн учурда мүмкүн болгон жалган мембраноздук колитти өнүгүү кооптуулун баалоо көз карашы тарабынан бейтаптын абалын баалоо керек. Бактерияга каршы препараттарды кабыл алуу, ашказан-ичегиден кадимки абалдагы флорасын өзгөртөт, бул клостридиянын ашыкча көбөйүп кетишине шарт түзөт. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, *Clostridium difficile* өндүргөн токсин антибиотикке байланыштуу колиттин өнүгүшүнүн түпкү себеби болуп саналат. Жалган мембраноздуу колит диагнозу коюлганда, тиешелүү дарылык чаралар көрүлөт. Оорунун жеңил түрүндө көпчүлүк учурда бактерияга каршы препаратты токтотуу жетиштүү. Суперинфекциянын орточо-оор жүрүшүндө *Clostridium difficile* тарабынан козголгон колитте өзүнүн натыйжалуулугун далилдеген антиотиктерди жана амин кислоталык тамактанууну, электролиттерди жана суюктуктарды дайындоо зарылчылыгын карап чыгуу зарыл.

Бактерияга каршы дарылоону жүргүзүүдө мите козу карындык жана бактериялык мүнөздөгү супер инфекциялардын өнүгүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө эстен чыгарбоо керек. Супер инфекциялардын өнүгүшү менен, Амодакс препаратын токтотуу жана тиешелүү патогенетикалык дарылоо дайындалышы керек.

Мононуклеоз менен ооруган бейтаптарда амоксициллинди кабыл алуунун фонунда эритематоздуу теринин бөртмөсүнүн өнүгүп кетүү коркунучу жогору, буга байланыштуу бул антибиотик мононуклеоз менен бейтаптарга каршы көрсөтүлөт.

Далилденген бактериялык инфекция жок болгон учурда же анын бар экендиги жөнүндө негизделген шектенүүлөр жок болгон учурда Амодакс препараттын алдын алуу үчүн дайындоо бейтап үчүн күмөндүү пайда алып келет жана антибиотикке бактериялык туруктуулукту жогорулатуу коркунучун жогорулатат.

Жаңы төрөлгөн ымыркайлар менен бөбөктөрдүн бөйрөк функциясы жетишсиз болгондуктан, амоксициллиндин бөлүнүп чыгарылышы жай болушу мүмкүн. Амодакс препараттын 3 айга чейинки курактагы балдарга дайындоо элиминациянын төмөндөшүн эске алуу менен жүргүзүлүшү керек.

Бөйрөк функциясынын бузулушу улгайган бейтаптарда көп кездешкендиктен жана бөйрөк функциясы бузулган учурда токсиндүү реакциялардын пайда болуу коркунучу жогорулагандыктан, дозаны тандоодо этияттыкты сактоо керек. Бөйрөк функциясына үзгүлтүксүз көзөмөл жүргүзүү сунушталат.

Кош бойлуулук жана бала эмизүү мезгили

Кош бойлуу аялдарга Амодакс препараттын колдонуу, эгерде эне жана түйүлдүк үчүн мүмкүн болгон коркунучтан кыйла ашып түшкөн учурда гана мүмкүн болот.

Пенициллиндер эне сүтүнө бөлүнүп чыгат. Эмчек эмизүү учурунда колдонуу баланын сезимтал болушуна шарт түзүшү мүмкүн. Күтүлгөн пайда потенциалдуу тобокелдиктен ашып түшкөн учурда гана, эмчек эмизүүдө Амодакс препараттын дайындоого болот жана этияттык менен мамиле кылуу керек.

Дары каражатынын транспорт каражатын жана башка механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө тийгизген таасиринин өзгөчөлүктөрү

Препараттын сунуш кылынган дозада автомобилди башкаруу же механизмдер менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө болгон терс таасири жөнүндө маалыматтар жок.

Чыгаруу формасы

Амодакс 125мг/5мл

60 мл желим бутылкада ичип кабыл алуу үчүн суспензияны даярдоого арналган порошок. Бир бутылка медицинада колдонуу боюнча нускамасы жана ченем стаканы менен бирге картон таңгакчада.

Амодакс 250мг/5мл

100 мл янтар түсүндөгү айнек бутылкада ичип кабыл алуу үчүн суспензияны даярдоого арналган порошок.

Бир бутылка медицинада колдонуу боюнча нускамасы жана ченем стаканы менен бирге картон таңгакчада.

Сактоо шарты

Кургак, жарыктан корголгон жерде, 25°C дан жогору эмес аба табында сактоо керек. Балдар жетпеген жерде сактоо зарыл.

Жарактуулук мөөнөтү

2 жыл. Даярдалган суспензияны бөлмө аба табында сактоо керек жана 7 сутка аралыгында кабыл алуу зарыл!

Жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин колдонууга болбойт!

Берүү шарты

Дарыгердин рецепти боюнча.

Үчүн өндүрүлдү/Manufactured for

NEO UNIVERSE LLP

Averley House Farm Hinckley Road,

Sapcote, Leicestershire,

LE9 4LH, United Kingdom (Улуу Британия)

Өндүрүүчү/Manufactured by

BRAWN LABORATORIES LIMITED

13, NIT, Industrial Area,

Faridabad-121001, Haryana, India (Индия)

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүмдүн (товардын) сапаты боюнча арыз-доолорду кабыл алуучу уюмдун дареги:

«Аман Фарм» ЖЧК (Аман Фарм), Кыргызстан Республикасы, Бишкек шаары,

Шоорукова көч. 36.

Тел: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com